

57★★★★
☑☑☑

悪性胸膜中皮腫の胸水細胞診検査では、Papanicolaou 染色、Giemsa 染色、PAS 染色などの通常の染色のみで診断を行うことは推奨されず、**セルブロック**を作成して免疫染色を行い検討する。

58★★★★
☑☑☑

悪性胸膜中皮腫の予後は、無治療での中間生存期間をみると肉腫型では 13 ヶ月であるが、上皮型では 4 ヶ月とされている。

59★★★★
☑☑☑

悪性胸膜中皮腫の病理学検査では、免疫染色でサイトケラチン以外に 2 種以上の中皮腫のマーカーと 2 種以上の癌のマーカーを検討する。

60★★★★
☑☑☑

悪性中皮腫と癌の鑑別には、calretinin、WT-1、D2-40、CK5/6 による免疫染色が有用である。

61★★★★
☑☑☑

悪性中皮腫と反応性中皮過形成との鑑別には、間質や脂肪組織への浸潤の有無が重要な所見となる。

62★★★★
☑☑☑

胸膜中皮腫の診断において、胸水中のヒアルロン酸はカットオフを 100,000 ng/mL とすれば感度は 90% 以上となる。

63★★★★
☑☑☑

悪性胸膜中皮腫に対するニボルマブ単剤療法は二次治療薬として承認されている。

64★★★★
☑☑☑

局所麻酔下胸腔鏡検査は十分な量の生検検体を採取可能であり、経皮針生検より高い診断能をもつ。

65★★★★
☑☑☑

悪性胸膜中皮腫のうち、一般的に手術適応となるのは肉腫型である。

66★★★★
☑☑☑

悪性胸膜中皮腫の手術術式として、近年は壁側胸膜と肺表面の臓側胸膜のみを切除し肺を温存する**胸膜切除 / 肺剥皮術 (Pleurectomy/Decortication: P/D)** が主流となっている。

67★★★★
☑☑☑

ニボルマブとイピリムマブの併用療法は、未治療の切除不能悪性胸膜中皮腫に対する一次治療薬として承認されている。

68★★★★
☑☑☑

良性石綿胸水はアスベスト曝露から数年以内に発症することが多い。

69★★★★
☑☑☑

良性石綿胸水はしばしば円形無気肺を合併する。